

Guía clínica: Trastorno de Pánico

El trastorno de pánico implica ataques de pánico recurrentes e inesperados y preocupación persistente por nuevos ataques o sus consecuencias. Guía para evaluación e intervención.

1. Características del ataque de pánico

Un ataque de pánico es un episodio de miedo o malestar intenso de inicio brusco que alcanza su pico en minutos y se acompaña de al menos 4 de los siguientes síntomas:

Síntomas físicos	Síntomas cognitivos
Palpitaciones / taquicardia Sudoración Temblor o sacudidas Sensación de ahogo Dolor u opresión en el pecho Náuseas / malestar abdominal Mareo / inestabilidad Parestesias (hormigueo) Escalofríos o sofoco	Desrealización / despersonalización Miedo a perder el control o "volverse loco/a" Miedo a morir

2. Modelo cognitivo del pánico (Clark, 1986)

Disparador → Sensación corporal → Interpretación catastrófica ('me estoy muriendo / perdiendo el control') → Aumento de la ansiedad → Más sensaciones → Ataque de pánico. La intervención apunta a interrumpir este ciclo.

3. Factores de mantenimiento

- Hipervigilancia a sensaciones corporales: cualquier sensación se convierte en señal de peligro.
- Interpretaciones catastrofistas de síntomas físicos normales.
- Evitación de situaciones, lugares o actividades asociadas a los ataques.
- Conductas de seguridad que impiden la desconfirmación de las creencias amenazantes.
- Ansiedad anticipatoria que aumenta la activación y facilita nuevos ataques.

4. Intervención: fases recomendadas

Psicoeducación	Explicar el modelo cognitivo. Normalizar los síntomas físicos. Romper el misterio del pánico.
Reestructuración cognitiva	Identificar y cuestionar interpretaciones catastrofistas de sensaciones corporales.
Técnicas de regulación	Respiración diafragmática (con precaución), relajación muscular progresiva.

Exposición interoceptiva	Inducir deliberadamente sensaciones temidas para desconfirmar su peligrosidad.
Exposición situacional	Abordar gradualmente situaciones evitadas. Eliminar conductas de seguridad.

5. Notas importantes

- Descartar causas médicas antes o en paralelo al inicio del tratamiento.
- La respiración controlada puede ser contraproducente si se convierte en conducta de seguridad.
- La exposición interoceptiva es el componente más específico y eficaz para el trastorno de pánico.

Notas clínicas

<i>Descripción del primer ataque y contexto de aparición:</i>
<i>Conductas de seguridad y evitaciones identificadas:</i>